

Grille d'évaluation ECOS - USMLE-17 - Perte auditive - Homme de 75 ans

Cabinet médical

Paul Stout, 75 ans, se présente au cabinet en se plaignant de perte auditive

TA 132/68 mmHg	FC 84 bpm	FR 18/min	T° 36.9°C
-------------------	--------------	--------------	--------------

Anamnèse (25%)

Score : 0/40

Critères	Oui	±	Non	Points
1. Motif principal [Je n'entends plus aussi bien qu'avant]	☐		☐	0
2. Caractérisation de la perte auditive				0
Description [Ma femme m'a dit que je n'entends pas bien, et dernièrement, j'ai remarqué que je lisais sur les lèvres]	☐			
Début [Cela dure depuis un an]	☐			
Progression [Cela s'aggrave]	☐			
Localisation [Il semble que j'ai des problèmes dans les deux oreilles, mais je ne suis pas sûr]	☐			
Type de sons [Rien de spécifique]	☐			
Mots brouillés [Oui, surtout dans les endroits bondés ou quand je regarde la télévision]	☐			
Localisation source sonore [Oui, je peux localiser]	☐			
Compréhension parole [Non, pas de problème]	☐			
3. Traitements antérieurs				0
Traitements essayés [J'ai vu mon médecin il y a un mois, et il m'a nettoyé du cérumen des oreilles. Cela m'a semblé aider pendant un certain temps, mais maintenant c'est aussi mauvais qu'avant]	☐			
Efficacité [Non]	☐			
4. Symptômes associés ORL				0
Douleur oreille [Non]	☐			
Écoulement [Non]	☐			
Vertiges rotatoires [Non]	☐			
Déséquilibre [Non]	☐			
Acouphènes [Parfois, dans les deux oreilles]	☐			
Corps étranger [Non]	☐			
Nausées/vomissements [Non]	☐			
5. Facteurs de risque				0
Traumatisme oreilles [Non]	☐			
Exposition bruits forts [Oui. J'étais dans l'armée, et c'était toujours bruyant]	☐			
Infections récentes [J'ai eu une infection urinaire il y a environ un an. Mon médecin m'a donné un antibiotique, mais je ne me souviens pas de son nom]	☐			
6. Symptômes neurologiques				0
Céphalées [Rarement]	☐			
Faiblesse musculaire [Non]	☐			
Perte sensibilité [Non]	☐			
Engourdissement/picotements [Non]	☐			

7. Antécédents médicaux				0
Pathologies connues [Hypertension. Je prends ma tension tous les jours, et elle est bien contrôlée]		☐		
Antécédents familiaux surdité [Non]		☐		
8. Antécédents chirurgicaux [Aucun]		☐	☐	0
9. Médicaments actuels				0
Antihypertenseurs [Hydrochlorothiazide]		☐		
Autres médicaments [Depuis 25 ans, je prends aussi de l'aspirine tous les jours pour protéger mon cœur]		☐		
10. Profession [Militaire à la retraite]		☐	☐	0
11. Mode de vie				0
Alcool [Jamais]		☐		
Drogues illicites [Jamais]		☐		
Tabagisme [Jamais]		☐		
Activité sexuelle [Seulement avec ma femme]		☐		
12. Allergies médicamenteuses [J'ai une éruption cutanée quand je prends de la pénicilline]		☐	☐	0

Examen clinique (25%)			Score : 0/25	
Critères	Oui	±	Non	Points
1. État général [Le patient ne semble pas en détresse aiguë]	☐		☐	0
2. Tests auditifs				0
Test audition de dos [Difficulté à entendre]	☐			
Test du chuchotement [Diminué bilatéralement]	☐			
Test de Weber [Centré]	☐			
Test de Rinne [Positif (CA > CO) bilatéralement]	☐			
3. Examen ORL				0
Otoscopie [Pas de cérumen. Membrane tympanique avec réflexe lumineux, pas de signes d'infection, pas de rougeur du conduit auditif]	☐			
Palpation auriculaire [Pas de douleur de l'auricule ou de la région péri-auriculaire]	☐			
Inspection nez/sinus [Normaux]	☐			
Inspection bouche/gorge [Oropharynx normal]	☐			
Palpation cervicale [Pas d'adénopathie]	☐			
4. Examen ophtalmologique				0
Pupilles [Iso-iso]	☐			
Mouvements oculaires [Normaux]	☐			
Nystagmus [Absent]	☐			
Fond d'œil [Pas d'œdème papillaire]	☐			
5. Examen cardiovasculaire	☐	☐	☐	0
Auscultation [RR et FC normaux, B1/B2 normaux, pas de souffles, frottements, ou galops]				
6. Examen pulmonaire	☐	☐	☐	0
Auscultation [Murmures vésiculaires clairs bilatéralement]				

7. Examen neurologique

0

- Nerfs crâniens [II-XII intacts sauf pour une diminution de l'audition] ☐
- Force musculaire [5/5 partout] ☐
- Sensibilité [Intacte] ☐
- ROT [2+ partout] ☐
- Démarche [Normale] ☐
- Épreuves cérébelleuses [Doigt-nez et talon-genou négatifs] ☐

Management (25%)

Score : 0/26

Critères	Oui	±	Non	Points
1. Hypothèses diagnostiques	☐	☐	☐	0

2 points si au moins 2 diagnostics pertinents mentionnés, 1 point si 1 diagnostic

Diagnostics différentiels à considérer

Causes neurosensorielles

• Presbyacousie → Audiométrie tonale et vocale

Arguments POUR:

- ☐ Âge avancé (75 ans)
- ☐ Perte auditive bilatérale progressive
- ☐ HTA chronique (atteinte vasculaire cochlée)
- ☐ Mots brouillés dans le bruit
- ☐ Test de Rinné positif (CA > CO)
- ☐ Weber centré

Physiopathologie:

- ☐ Dégénérescence cellules ciliées
- ☐ Atteinte vasculaire cochlée

• Trauma acoustique chronique → Audiométrie (encoche 4000 Hz)

Arguments POUR:

- ☐ Exposition militaire prolongée
- ☐ Perte auditive bilatérale
- ☐ Acouphènes bilatéraux
- ☐ Test de Rinné positif
- ☐ Weber centré

Mécanisme:

- ☐ Lésion cellules ciliées externes
- ☐ Atteinte fréquences 4000 Hz

• Ototoxicité médicamenteuse → Arrêt aspirine, réévaluation

Arguments POUR:

- ☐ Aspirine chronique (25 ans)
- ☐ Acouphènes bilatéraux
- ☐ Perte auditive progressive

Arguments CONTRE:

- ☐ Ototoxicité aspirine réversible
- ☐ Pas d'autres symptômes toxiques

Causes conductrices

• Otosclérose → Impédancemétrie, scanner temporal

Arguments POUR:

- ☐ Âge compatible
- ☐ Perte auditive progressive
- ☐ Bilatérale

Arguments CONTRE:

- ☐ Test Rinné positif (attendrait négatif)
- ☐ Pas d'antécédent familial
- ☐ Tympan normaux

• Bouchon de cérumen récidivant → Otoscopie de contrôle régulière

Arguments POUR:

- ☐ Amélioration temporaire après nettoyage

Arguments CONTRE:

- ☐ Otoscopie normale actuellement
- ☐ Perte neurosensorielle objective

Causes mixtes

• Maladie de Ménière → Électronystagmographie, IRM

Arguments POUR:

- ☐ Acouphènes bilatéraux
- ☐ Perte auditive

Arguments CONTRE:

- ☐ Pas de vertiges rotatoires
- ☐ Pas de crises typiques
- ☐ Bilatéral (souvent unilatéral)

• **Neurinome acoustique bilatéral** → *IRM cérébrale avec gadolinium*

Arguments POUR:

- ☐ Perte auditive progressive
- ☐ Acouphènes

Arguments CONTRE:

- ☐ Bilatéral (très rare)
- ☐ Pas de déficit neurologique
- ☐ Pas de déséquilibre

2. Examens complémentaires urgents

0

- Audiométrie tonale et vocale complète ☐
- Impédancemétrie (tympantométrie + réflexes stapédiens) ☐
- Otoscopie bilatérale approfondie ☐
- Arrêt aspirine immédiat (test thérapeutique) ☐

3. Examens complémentaires selon évolution

0

- Potentiels évoqués auditifs (PEA) si neuropathie suspectée ☐
- Scanner des rochers si otosclérose suspectée ☐
- IRM cérébrale si asymétrie ou signes neurologiques ☐
- Bilan vasculaire (doppler carotidien) si facteurs de risque ☐
- Sérologie syphilis si Ménière atypique ☐

4. Prise en charge immédiate



0

Mesures conservatrices

- Arrêt aspirine (ototoxicité réversible)
- Optimisation contrôle HTA
- Protection auditive si exposition sonore
- Positionnement face à l'interlocuteur
- Réduction bruit ambiant
- Parler clairement, pas plus fort

Aides techniques

- Consultation audioprothésiste
- Appareillage auditif bilatéral probable
- Essai 30 jours obligatoire
- Systèmes d'assistance (boucle magnétique)
- Applications smartphone amplification
- Sous-titrage TV/téléphone adapté

Support et adaptation

- Information sur presbyacousie
- Groupes de soutien malentendants
- Formation lecture labiale
- Adaptation domicile (alarmes visuelles)
- Implication de l'épouse
- Associations spécialisées

5. Référence spécialisée

0

- ORL pour bilan complet ☐
- Audioprothésiste pour appareillage ☐
- Orthophoniste si troubles compréhension ☐
- Gériatre pour bilan global ☐
- Cardiologue pour optimisation HTA ☐

6. Suivi et surveillance

0

- Audiométrie annuelle ☐
- Adaptation prothèses régulière ☐
- Surveillance fonction rénale (diurétiques) ☐
- Dépistage dépression (isolement social) ☐
- Évaluation risque chutes ☐
- Maintien vie sociale active ☐

7. Signes d'alarme à surveiller



0

⚠ Red Flags - Urgences ORL

1. **Surdit  brusque unilat rale**
→ Urgence ORL = Cortico ides dans les 48h
2. **Vertiges rotatoires intenses**
→ M ni re, n vrite = Consultation urgente
3. **D ficit neurologique focal**
→ AVC/tumeur = IRM c r brale urgente
4. **Otorrh e purulente**
→ Otite chronique = Antibioth rapie
5. **Douleur auriculaire intense**
→ Otite externe maligne = Hospitalisation si diab te

Cl ture de consultation

Cl ture type

Monsieur Stout, je sais que vous  tes pr occup  par votre probl me. Je peux confirmer que vous avez une certaine perte auditive. Je souhaiterais r aliser plusieurs tests, y compris des analyses de sang. Je voudrais  galement que vous cessiez de prendre de l'aspirine, car cela pourrait contribuer   votre perte auditive. Je vais vous r f rer   un audiom triste, qui vous  valuera pour un appareil auditif. Avez-vous des questions pour moi ?

Questions difficiles   poser

[Est-ce que vous pensez que je deviens sourd ?]

R ponse type du candidat

Vos sympt mes et les r sultats de mon examen montrent que vous avez un certain d ficit auditif. Nous devons faire plus de tests pour d terminer la cause du probl me, si cela va s'aggraver, et si nous pouvons en stopper la progression ou am liorer votre audition. En attendant, je vous recommande de cesser de prendre de l'aspirine.

Communication (25%)

Score : 0/20

Crit�res	A	B	C	D	E
1. R�ponse aux sentiments et besoins du patient <i>Empathie, �coute active, validation des �motions Explique le d�roulement de la consultation et v�rifie les pr�occupations du patient, commence l'anamn�se par une question ouverte ; reconna�t, verbalise et l�gitime les �motions, fournit du soutien</i>	☐	☐	☐	☐	☐
2. Structure de l'entretien <i>Organisation logique, transitions fluides, gestion du temps Se pr�sente par son nom et sa fonction, les �tapes de l'entretien sont identifiables et s'encha�nent de mani�re logique, gestion du temps, adaptation � la situation</i>	☐	☐	☐	☐	☐
3. Expression verbale <i>Clart�, vocabulaire adapt�, v�rification de la compr�hension Langage adapt� au niveau du patient, pas de jargon, explications compr�hensibles, reformulations quand n�cessaire, r�p�titions des points cl�s, fait une synth�se de la consultation, bonne articulation, ton et volume ad�quats</i>	☐	☐	☐	☐	☐
4. Expression non verbale <i>Contact visuel, posture, gestuelle appropri�e Distance interpersonnelle ad�quate, posture ad�quate, gestes ad�quats, contact visuel et expression faciale ad�quats, pauses quand n�cessaire</i>	☐	☐	☐	☐	☐
5. �valuation g�n�rale de la communication <i>Qualit� globale de l'interaction m�decin-patient</i>	☐	☐	☐	☐	☐

Scénario pour le patient standardisé

Nom : Paul Stout | **Âge :** 75 ans

Contexte : Homme marié, militaire retraité, hypertendu bien contrôlé

Motif de consultation

Plainte principale : «Je n'entends plus aussi bien qu'avant.»

Si on demande s'il y a autre chose : «Ma femme dit que je parle trop fort et que je monte le volume de la télé.»

Consignes

- Demander au candidat de parler plus fort si vous ne l'entendez pas bien.
- Faire semblant d'avoir des difficultés à entendre dans les deux oreilles.
- Montrer que vous n'avez pas de latéralisation au test de Weber.
- Faire semblant de ne pas entendre lorsque vous êtes abordé de derrière.
- Lire sur les lèvres de manière évidente.

Histoire actuelle

Perte auditive :

- Progressive depuis 1 an
- Bilatérale
- Mots brouillés dans le bruit
- Lecture labiale compensatrice
- Épouse remarque le problème

Traitements :

- Extraction cérumen il y a 1 mois
- Amélioration temporaire seulement

Symptômes associés :

- Acouphènes bilatéraux occasionnels
- Pas de vertiges
- Pas d'écoulement
- Céphalées rares

Habitudes

- **Toxiques :** Aucun (ni tabac, ni alcool, ni drogues)
- **Activité :** Retraité actif
- **Contexte social :** Marié, vie sociale normale

Antécédents

Antécédents médicaux :

- HTA depuis 25 ans, bien contrôlée
- Infection urinaire il y a 1 an

Exposition :

- Service militaire bruyant
- Pas de protection auditive à l'époque

Médicaments :

- Hydrochlorothiazide pour HTA
- Aspirine quotidienne depuis 25 ans

Simulation

Durant l'entretien :

- Pencher la tête vers l'avant
- Regarder les lèvres du candidat
- Demander de répéter fréquemment
- Parler un peu plus fort que normal
- Sourire pour masquer la gêne

Durant le status :

- Coopération totale
- Difficulté test chuchotement
- Weber non latéralisé
- Rinné positif (mimer compréhension)
- Pas de douleur à l'examen

Informations de l'expert

Dossier médical de l'entretien

Homme de 75 ans avec presbyacousie typique aggravée par exposition sonore militaire chronique. Possible composante ototoxique (aspirine au long cours). HTA facteur de risque vasculaire cochlée. Indication claire d'appareillage auditif bilatéral.

Rôles et interventions de l'expert·e

L'expert·e intervient si l'étudiant·e demande :

- Audiométrie : perte neurosensorielle bilatérale prédominant sur aigus
- Courbe en pente de ski typique
- Discrimination vocale : 60% à 40 dB
- Tympanométrie : normale (type A)
- Réflexes stapédiens : présents mais seuils élevés

Points clés

- Presbyacousie = 1ère cause surdité personne âgée
- Exposition sonore militaire = facteur aggravant
- Arrêt aspirine peut améliorer acouphènes
- Appareillage précoce = meilleure adaptation
- Impact social majeur de la surdité

Pièges

- Ne pas arrêter l'aspirine
- Oublier référence audioprothésiste
- Minimiser l'impact social
- Ne pas impliquer l'épouse
- Promettre guérison impossible

Diagnostic

Presbyacousie bilatérale avec composante de trauma sonore chronique (exposition militaire) et possible ototoxicité médicamenteuse (aspirine)

Épidémiologie de la presbyacousie

Première cause de surdit  acquise :

- Prévalence : 30% > 65 ans, 60% > 75 ans
- Facteur génétique : 50% héritabilité
- Hommes > femmes (exposition sonore)
- Coût socio-économique majeur
- Sous-diagnostiquée et sous-appareillée
- Association déclin cognitif et dépression

Physiopathologie

Atteinte cochléaire multifactorielle :

- Dégénérescence cellules ciliées externes
- Perte neurones ganglion spiral
- Atrophie strie vasculaire
- Modifications biochimiques endolymphes
- Atteinte préférentielle hautes fréquences
- Aggravation par facteurs vasculaires

Types de presbyacousie

Classification histopathologique :

- Sensorielle : perte cellules ciliées (HF)
- Neurale : dégénérescence neurones
- Métabolique : atrophie strie vasculaire
- Mécanique : rigidité membrane basilaire
- Mixte : la plus fréquente
- Indéterminée : 25% des cas

Trauma sonore chronique

Exposition professionnelle/militaire :

- Seuil dangereux : > 85 dB pendant 8h
- Armée : exposition 110-180 dB
- Lésions irréversibles cellules ciliées
- Encoche caractéristique 4000 Hz
- Synergie avec presbyacousie
- Prévention : protection auditive obligatoire

Ototoxicité médicamenteuse

Médicaments à risque :

- Aspirine : réversible, dose-dépendant
- Aminosides : irréversible, monitoring
- Diurétiques de l'anse : réversible
- Cisplatine : irréversible, cumulatif
- Quinine : acouphènes +++
- Surveillance audiométrique si exposition

Évaluation audiolologique

Bilan complet nécessaire :

- Audiométrie tonale : seuils par fréquence
- Audiométrie vocale : discrimination
- Impédancemétrie : oreille moyenne
- Otoémissions : fonction cochléaire
- PEA si doute rétrocochléaire
- Questionnaires handicap (HHIE)

Appareillage auditif

Indications et modalités :

- Perte > 30 dB sur parole
- Gêne sociale significative
- Appareillage bilatéral préférable
- Technologies numériques actuelles
- Période essai 30 jours obligatoire
- Remboursement partiel selon pays

Alternatives thérapeutiques

Options complémentaires :

- Implants oreille moyenne (surdit  mixte)
- Implant cochl aire si surdit  profonde
- Aides techniques : boucle magn tique
- R  ducation orthophonique
- Lecture labiale syst matique
- Applications smartphone

Impact psychosocial

Cons quences multiples :

- Isolement social progressif
- Risque d pression x2
- D clin cognitif acc l r 
- Risque d mence augment 
- Accidents (non perception alarmes)
- Qualit  de vie diminu e

Pr vention

Mesures protectrices :

- Protection auditive si > 85 dB
- Contr le facteurs cardiovasculaires
-  viction m dicaments ototoxiques
- D pistage audiom trique r gulier
- Traitement pr coce otites
- Mode de vie sain (exercice, alimentation)

Messages cl s

- Presbyacousie = vieillissement normal mais traitable
- Facteurs aggravants souvent pr sents
- Arr t aspirine peut am liorer sympt mes
- Appareillage pr coce = meilleure qualit  de vie
- Approche multidisciplinaire n cessaire
- Impact social/cognitif   ne pas n gliger
- Implication entourage essentielle
- Technologies modernes tr s efficaces

Rappels thérapeutiques

- Arrêt aspirine si ototoxicité suspectée
- Protection auditive si exposition sonore
- Appareillage auditif bilatéral
- Optimisation traitement HTA
- Support psychosocial

Examens complémentaires

- Audiométrie complète obligatoire
- Impédancemétrie systématique
- IRM si asymétrie > 15 dB
- PEA si doute diagnostic
- Bilan vasculaire si FDR multiples